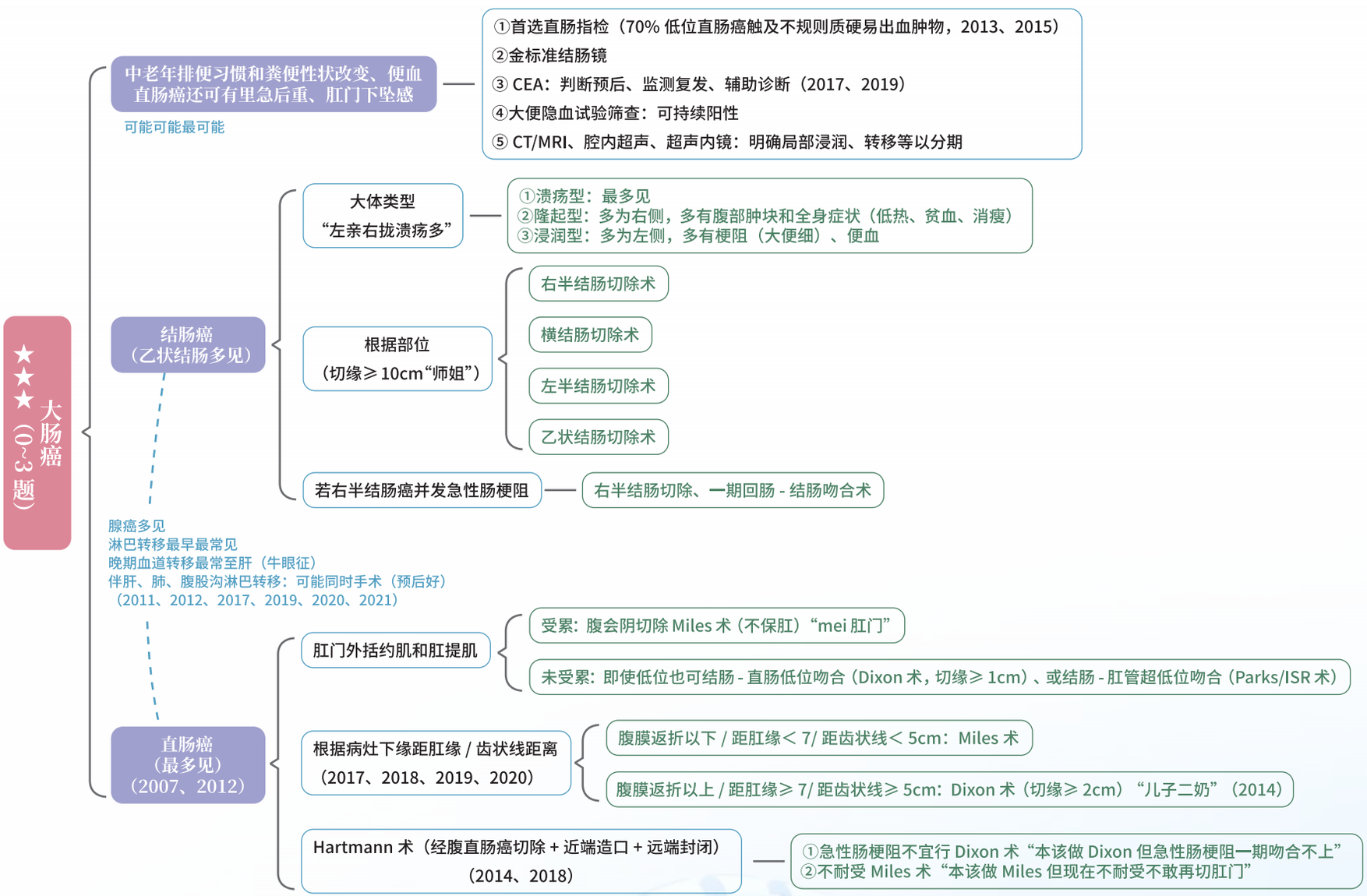

★★★ 大肠癌（0~3题）
中老年排便习惯和粪便性状改变、便血
直肠癌还可有里急后重、肛门下坠感
可能可能最可能
①首选直肠指检（70% 低位直肠癌触及不规则质硬易出血肿物，2013、2015）
②金标准结肠镜
③ CEA：判断预后、监测复发、辅助诊断（2017、2019）
④大便隐血试验筛查：可持续阳性
⑤ CT/MRI、腔内超声、超声内镜：明确局部浸润、转移等以分期
结肠癌
（乙状结肠多见）
腺癌多见
淋巴转移最早最常见
晚期血道转移最常至肝（牛眼征）
伴肝、肺、腹股沟淋巴转移：可能同时手术（预后好）
（2011、2012、2017、2019、2020、2021）
大体类型
“左亲右拢溃疡多”
①溃疡型：最多见
②隆起型：多为右侧，多有腹部肿块和全身症状（低热、贫血、消瘦）
③浸润型：多为左侧，多有梗阻（大便细）、便血
根据部位
（切缘≥ 10cm“师姐”）
右半结肠切除术
横结肠切除术
左半结肠切除术
乙状结肠切除术
若右半结肠癌并发急性肠梗阻
右半结肠切除、一期回肠 - 结肠吻合术
直肠癌
（最多见）
（2007、2012）
肛门外括约肌和肛提肌
受累：腹会阴切除 Miles 术（不保肛）“mei 肛门”
未受累：即使低位也可结肠 - 直肠低位吻合（Dixon 术，切缘≥ 1cm）、或结肠 - 肛管超低位吻合（Parks/ISR 术）
根据病灶下缘距肛缘 / 齿状线距离
（2017、2018、2019、2020）
腹膜返折以下 / 距肛缘＜ 7/ 距齿状线＜ 5cm：Miles 术
腹膜返折以上 / 距肛缘≥ 7/ 距齿状线≥ 5cm：Dixon 术（切缘≥ 2cm）“儿子二奶”（2014）
Hartmann 术（经腹直肠癌切除 + 近端造口 + 远端封闭）
（2014、2018）
①急性肠梗阻不宜行 Dixon 术“本该做 Dixon 但急性肠梗阻一期吻合不上”
②不耐受 Miles 术“本该做 Miles 但现在不耐受不敢再切肛门”